

第9期高齢者保健福祉・介護保険・認知症施策計画の年次進捗管理及び区別見える化の推進に関する議案

English title: Proposal to Strengthen Annual Progress Monitoring and Ward-Level Transparency for Yokohama City's 9th Elderly Welfare, Long-Term Care Insurance, and Dementia Measures Plan

対象自治体: 横浜市

1. 本文

横浜市は、市第113号議案「第9期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画の策定」が可決され、かつ市の案内ページにおいて当該計画の計画期間が「令和6年度から8年度」と示されていることを前提に、当該計画の実施状況を毎年度点検し、市民に分かる形で公表する。〔横浜市会 議案〕市第113号議案（可決）／（Web）「よこはまポジティブエイジング計画（第9期計画期間：令和6年度から8年度）」

1. 対象

2. 対象は、第9期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画に含まれる全施策とする。〔横浜市会 議案〕市第113号議案／（Web）同上
3. 施策ごとに、全市集計が可能なものは全市単位で、区別把握が可能なものは区単位で整理する。
4. 個人情報保護、秘匿性、又は集計上の制約により区別公表が困難な項目は、その理由を明記したうえで全市集計にとどめる。

5. 実施主体

6. 実施主体は横浜市とする。

7. 総括は健康福祉局が担い、各区役所、介護保険所管部門、認知症施策所管部門が必要な集計・点検を行う。

8. 公表資料の取りまとめは健康福祉局が行う。

9. 既存の会議体、審議会、意見聴取、アンケート、ヒアリング等の既存手法を優先し、追加調査は必要最小限とする。

10. 実施内容

11. 各年度末に、施策ごとの実施状況、未着手事項、遅延事項、翌年度の改善方針を整理する。
12. 可能な施策については、区別の実施状況を併記する。

13. 認知症施策については、当事者および家族の意見を、既存の会議体や既存調査を通じて収集し、点検結果に反映する。
14. 年次点検の結果は、翌年度の事業設計および予算要求に反映する。
15. 公表資料には、少なくとも「施策名」「年度内の実施状況」「課題」「翌年度対応」「区別に把握できる場合は区別数値」を含める。
16. 公表は市のウェブサイトの基本とし、必要に応じて市会報告資料、区役所窓口掲示、広報紙掲載を併用する。
17. 公表資料は、各年度末から原則として3か月以内に公開する。
18. 年度ごとの公表様式は統一し、前年度比較が可能な形式とする。
19. 区別集計が可能な指標については、同一の定義・集計期間・算出方法を用いて掲載する。
20. 期間
21. 実施期間は、第9期計画期間である令和6年度から令和8年度までとする。（Web）同上
22. 初回の年次公表は令和6年度実績分について行い、その後、毎年度継続する。
23. 令和8年度末には、3年間の総括を行う。
24. 総括では、年度別の進捗、区別差、未達施策の改善状況、認知症施策への意見反映状況を整理する。
25. 財源
26. 初年度は既存予算の範囲内で実施する。
27. 新たに必要となる経費が生じる場合は、翌年度以降の当初予算に必要最小限を計上する。
28. 区別集計や公表資料作成に関する追加経費は、現時点では公的根拠に基づく確定額が示されていないため、実績に基づき精査する。
29. 予算措置は、既存の情報公開・計画進行管理・広報業務の中で吸収できる範囲を優先する。
30. 追加のシステム改修が必要な場合は、紙・既存表計算・既存庁内共有基盤で代替できる範囲を先に検討する。
31. 運用上の留意事項
32. 区別公表は、各施策の性質上可能な範囲で行う。
33. 認知症施策の当事者・家族の意見は、既存の会議体や既存調査を優先して収集し、追加負担が過大にならない方法を採用する。
34. 進捗管理は、単なる報告にとどめず、翌年度の改善に確実に接続する運用とする。
35. 区別に公表できない指標については、非公表の理由を明記し、代替として全市集計を示す。
36. 個人情報保護に配慮し、少数件数の区別公表は、必要に応じて秘匿化又は集約化する。

2. 提案理由

横浜市では、第9期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画が可決され、その計画期間が令和6年度から8年度であることが市の案内ページで確認できる。〔横浜市会議案〕市第113号議案（可決）／（Web）「よこはまポジティブエイジング計画（第9期計画期間：令和6年度から8年度）」このため、当該計画は単年度の事業ではなく、複数年度にわたって実施状況を点検し、必要に応じて改善を重ねる前提で運用されるべきである。

高齢者福祉、介護保険、認知症施策は、利用需要や地域差が表れやすい分野である。区ごとの人口構成、相談導線、サービス供給状況は一様ではないため、全市平均だけでは課題の所在が見えにくい。区別が見える化があれば、地域差に応じた改善がしやすくなる。

また、認知症施策では、当事者や家族の実感に即した改善が重要である一方、行政の内部評価だけでは生活上の困難や制度の使いにくさが拾いにくい。既存の会議体や既存調査を活用して意見を集め、年次点検に反映する仕組みが必要である。

この提案は、新規の大規模事業を追加するものではない。既存の計画運用に「毎年度の点検」「区別が見える化」「認知症施策の意見反映」「翌年度への反映」を組み込むことで、計画を実効あるものにすることを目的とする。

現時点で確認できる公開情報は、議案の可決と計画期間であり、各施策の進捗管理の粒度、区別公表の可否、認知症施策への意見反映の具体的な運用は確認できていない。したがって、本議案は、確認済みの計画枠組みを前提に、未確認部分を市の運用として具体化するための提案である。

3. 検証計画

未解明の点 - 横浜市が現在、各施策をどの粒度で進捗管理しているかは未確認である。 - 区別に公表できる指標と、公表しにくい指標の切り分けは未確認である。 - 認知症施策について、既存の会議体や意見聴取だけで当事者・家族の意見を十分に把握できるかは未検証である。 - 年次公表に要する事務量と追加費用は、現時点で公的根拠が不足している。

収集するデータ - 各施策の実施件数、実施率、未着手項目、完了項目 - 区別の相談件数、利用件数、待機状況など、公表可能な指標 - 認知症施策に関する当事者・家族からの意見件数、改善反映件数 - 年次公表までに要した作業時間、資料作成件数、照会件数

収集主体と頻度 - 各所管部局が四半期ごとに集計する。 - 健康福祉局が年度末に総括し、年1回公表する。 - 区別データは、可能な範囲で各区役所が補助集計する。

効果判定の指標 - 計画施策の年度内実施率 - 未達施策の翌年度改善率 - 区別情報の公表率 - 認知症施策における意見反映件数 - 年次公表の期限遵守率 - 公表資料の更新遅延件数

パイロットの要否 - 全市一斉実施を基本とする。 - ただし、初年度は区別集計の負担や公表様式の妥当性を確認するため、既存の集計体制が整っている一部区で運用試行を行うことは有用である。 - 試行区、期間、成功基準は、現時点での根拠不足のため、実施直前に確定する。 - 成功基準は、年次公表を期限内に行えること、区別で公表可能な指標を無理なく整理できること、認知症施策への意見反映の流れを継続運用できることとする。 - 試行を行う場合は、試行区と非試行区の差を比較し、全市展開の可否を判断する。

4. 出典

- ・〔SearchLocalGov bill〕 議案番号 市第113号議案 「第9期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画の策定」 令和6年第1回定例会 議決結果:可決（取得日 2026-07-12）
- ・〔Web〕 ページ名「よこはまポジティブエイジング計画（第9期計画期間：令和6年度から8年度）」
URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kyogikai/chiihoukatsu-care/9kikeikaku.html?lang=ne&utm_source=openai（取得日 2026-07-12）